

VIVIEN LEAD MAGNET

A 12 tudományosan bizonyított szokás, ami csökkenti a demencia kockázatát

*A 2024-es nemzetközi tudományos
konszenzus alapján — a Lancet
Commission 12 módosítható kockázati
tényezője*

KÉSZÍTETTE

Stoiber Vivien

Demenciaszakértő · A demenciáról érthetően

DEMENCIAROLERTHETOEN.HU

A 12 tudományosan bizonyított szokás, ami csökkenti a demencia kockázatát

A 2024-es nemzetközi tudományos konszenzus alapján

Készítette: Vivien — demenciaszakértő Forrás-horgony: Lancet Commission on Dementia Prevention, Intervention and Care — 2020-as jelentés, 2024-es frissítés (Livingston G, et al.)

Köszöntő — mielőtt belekezdesz

Kedves Olvasó,

valószínűleg azért nyitottad meg ezt az anyagot, mert a családotban volt demencia. Talán egy nagyszülő, talán egy szülő. És azóta nem hagy nyugodni a kérdés: *velem is megtörténhet?*

Engedd meg, hogy az első mondatom ez legyen: nem vagy egyedül ezzel a gondolattal, és nem vagy paranoiás, hogy foglalkozol vele. A megelőzés a középkor egyik legfontosabb, legokosabb döntése — és pont az a generáció hagyja ki a legtöbbszor, amelyik a legtöbbet tehetne érte.

Ez a füzet nem ijesztgető anyag. Nem fog rád zúdítani 60%-os kockázatcsökkentést ígérő clickbait számokat. Nem fog kókuszolajat ajánlani.

Amit kapsz: a jelenlegi nemzetközi tudományos konszenzus — a Lancet Commission 2024-es frissített jelentése — letisztítva, magyarul, konkrét heti lépésekkel. És egy rövid, *érthető* szakasz a genetikáról, mert tapasztalatom szerint ez a leggyakoribb félreértés.

A jó hír, amit a Lancet Commission megfogalmaz: a demencia eseteinek **körülbelül 45%-a elméletileg megelőzhető vagy késleltethető** 12 módosítható tényező kezelésével. Nem mindenkinél. Nem garantáltan. De a hatás *valódi*, és minden évtized, amit egészséges aggyal töltesz, megéri a befektetést.

Olvasd lassan. Ne kezdj el holnap reggel mind a 12 dolgot. A végén találsz egy 7 napos protokollt, ami egyetlen hétre lebontva ad konkrét, kis lépéseket.

Veled vagyok ebben.

Vivien

A genetika mítosza — egy oldalas okos rész

Ez az a fejezet, amit a legtöbben átugranának. Kérlek, ne tedd.

Ha a családban előfordult demencia, valószínűleg már hallottad valakitől, hogy „ez genetikai, nem tudsz ellene tenni semmit”. Ez a mondat tudományosan pontatlan, és sok ember életét megmérgezi feleslegesen.

Két dolgot kell elkülönítened

1. Familiáris, korai kezdetű Alzheimer (early-onset autosomal dominant Alzheimer-kór). Ez az a fajta, ami valóban dominánsan öröklődik — három gén (APP, PSEN1, PSEN2) ritka mutációi okozzák, és általában 30–60 éves kor között jelentkezik. Az összes Alzheimer-eset **kevesebb mint 1%-a** ide tartozik. Ha a családban több, fiatalon (60 alatt) megbetegedett rokon volt, érdemes genetikai tanácsadáshoz fordulni — de ez a kivétel, nem a szabály.

2. Sporadikus, késői kezdetű Alzheimer. Ez a leggyakoribb forma (az esetek több mint 95%-a), és ez **nem dominánsan öröklődik**. Egy kockázati faktorhalmaz része — a genetika része ennek, de csak része.

Az APOE₄ gén — amit valószínűleg gugliztál

Az APOE gén három változata közül az ε₄ emeli a késői Alzheimer kockázatát.

- Ha egy APOE₄ alléled van (a populáció ~25%-a), az élethosszra vetített kockázatod **körülbelül 2–3-szorosára** nő.
- Ha két APOE₄ alléled van (a populáció ~2-3%-a), magasabb, de még itt sem 100%.
- **Az APOE₄ nem determinálja a demenciát.** Sok APOE₄-hordozó éli le az életét egészséges aggyal. Sok nem-hordozó kap demenciát.

Még fontosabb: a Lancet Commission 2024-es elemzése szerint az APOE₄-hordozók ugyanúgy profitálnak a 12 módosítható tényező kezeléséből, mint a nem-hordozók. A genetika *hajlamosít*, nem *ítél*.

A gyakorlati következtetés

Ne tesztelj APOE-ra impulzusból. Az eredmény (akár pozitív, akár negatív) nem változtat azon, mit kell tenned: ugyanazokat a megelőző lépéseket, amelyeket ebben a füzetben olvasol.

Ha a családi anamnézis vagy a szorongás indokolja, beszélj egy genetikai tanácsadóval, NEM egy direct-to-consumer DNS-céggel.

A 12 faktor

A következő oldalakon végigveszem a Lancet Commission 2024-es 12 módosítható kockázati tényezőjét, életkori sorrendben (korai életkor → középkor → idős kor).

Minden faktor mellett megtalálod:

- **A becsült populáció-szintű kockázati hányadot (PAF)** — ez azt fejezi ki, hogy *elméletileg* a demencia-esetek hány %-át lehetne megelőzni, ha az adott faktor teljesen eltűnne a populációban. Ez nem egyéni kockázatcsökkentés.
- **A bizonyíték minőségét.**
- **Egy konkrét lépést, amit ezen a héten megtehetsz.**
- **Egy emberi mondatot tőlem.**

Fontos: a PAF-ek nem adódnak össze egyszerűen, mert átfedések vannak. A teljes módosítható részesedés a Lancet 2024 szerint **~45%**.

01 — Iskolázottság / élethosszig tartó tanulás

PAF: ~5% · *Korai életkor* · Bizonyíték: erős

A kevesebb formális iskolázottság (különösen a 12 év alatti) a demencia egyik legrégebben dokumentált kockázati tényezője. A magyarázat: az iskola és a folyamatos tanulás építi az úgynevezett *kognitív tartalékot* — az agy ellenálló képességét a patológiai változásokkal szemben.

A jó hír: nem csak a fiatalkori iskolázottság számít. A felnőttkori, élethosszig tartó tanulás is védőhatású — egy új nyelv, egy hangszer, egy szakma, egy komoly hobbi.

Ezen a héten: Válassz egy témát, amit MOST nem értesz, és kezdj el róla heti egy könyvet, kurzust vagy podcastet. Nem agytorna-app. Valódi, struktúrált tudás.

„Az élethosszig tartó tanulás nem azért véd, mert produktívvá tesz. Azért véd, mert az agyat folyamatosan új mintákra kényszeríti — és az agy, ami sosem unatkozik, lassabban öregszik.”

Forrás: Livingston et al., Lancet 2024.

02 — Hallásvesztés-korrekción

PAF: ~7% · *Középkor* · Bizonyíték: erős (a legnagyobb egyetlen módosítható faktor)

A középkori, kezeletlen hallásvesztés a Lancet Commission elemzésében a legnagyobb egyetlen módosítható kockázati tényező. Két mechanizmust feltételeznek: a halló kéreg leépülése, és a szociális izoláció, ami a rossz halláshoz kapcsolódik.

A 2023-as ACHIEVE klinikai vizsgálat eredménye: magas rizikójú idősebb felnőtteknél a hallókészülék-használat 3 év alatt **48%-kal lassította** a kognitív hanyatlást a kontrollcsoporthoz képest.

Ezen a héten: Ha 50 év feletti vagy és nem mértek le hallásvizsgálattal az elmúlt 3 évben, foglalj időpontot. Egy egyszerű audiogramról van szó, nem invazív, 20-30 perc.

„A hallás visszaadása több, mint hallás — visszaadja a beszélgetéseket, és azzal a kapcsolataidat. Tudom, mennyire kínos egy hallókészüléket fontolóra venni 55 évesen. De az agyad nem kínos szempontokra figyel.”

Forrás: Livingston et al., Lancet 2024; Lin FR et al., ACHIEVE trial, Lancet 2023.

03 — Magas vérnyomás kezelése középkorban

PAF: ~2% · Középkor (40–65 év) · Bizonyíték: erős

A kezeletlen középkori magas vérnyomás (szisztolés ≥ 130 Hgmm) károsítja az agyi kisereket, ami évtizedekkel később vaszkuláris és kevert típusú demenciához vezet. A SPRINT-MIND vizsgálat (2019) mutatta, hogy a szigorúbb vérnyomáskontroll (cél: < 120 Hgmm) csökkenti az enyhe kognitív zavar kockázatát.

A célérték a Lancet Commission ajánlása szerint **130 Hgmm alatt szisztolés**, középkortól.

Ezen a héten: Ha az elmúlt 12 hónapban nem mértek vérnyomást nyugodt körülmények között, foglalj időpontot. Otthoni mérő ~10–15 ezer forintért elérhető, és a házi orvosod ad protokollt, hogyan mérd.

„A vérnyomás nem fáj. Pontosan ezért veszélyes — és pontosan ezért éri meg mérni akkor is, ha jól érzed magad.”

Forrás: Livingston et al., Lancet 2024; SPRINT-MIND, JAMA 2019.

04 — Dohányzás elhagyása

PAF: ~5% · *Bármely életkor* · Bizonyíték: erős

A dohányzás minden demencia-típus kockázatát emeli — gyulladásos, vaszkuláris és oxidatív mechanizmusokon keresztül. A jó hír: aki abbahagyja, *vissza tud nyerni rizikót*.

Egy 8 évvel az abbahagyás után mért kockázat már megközelíti a soha-nem-dohányzókét.

Tehát nem reménytelen, ha 55 évesen állsz le.

Ezen a héten: Ha dohányzol, dönts el a leszokás napját. Konkrét dátum. A magyar OEFI ingyenes leszokást támogató telefon-vonalat üzemeltet (06 80 442-244).

Nikotinpótlás + viselkedési támogatás kombinációja ~3-szor hatékonyabb, mint akarat egyedül.

„Soha nem találkoztam pácienssel, aki megbánta, hogy leszokott. Sokkal, aki azt mondta: bárcsak előbb.”

Forrás: Livingston et al., Lancet 2024.

05 — Elhízás és 2-es típusú cukorbetegség kezelése

PAF: ~1-2% · Középkor · Bizonyíték: közepes-erős

A középkori elhízás (BMI ≥ 30) és a 2-es típusú cukorbetegség egyaránt emeli a demencia kockázatát — részben a vaszkuláris hatáson, részben az inzulinrezisztencia agyi következményein keresztül. Az időskori BMI értelmezése bonyolultabb (paradoxnak tűnhet), ezért a középkor a kritikus időablak.

Ezen a héten: Ha még soha nem mértek HbA1c-t (cukorháztartás 3-havi átlaga), kérd a háziorvosodtól. Ha BMI-d magas, ne diétázz extrém módon — kérj táplálkozási tanácsadót, és gondolkozz hosszú távban.

„A testsúly nem morális kérdés. Egy adat, amivel dolgozni lehet — nyugodtan, türelmesen, év távlatában.”

Forrás: Livingston et al., Lancet 2024.

o6 — Depresszió kezelése

PAF: ~3% · *Középkor és időskor* · Bizonyíték: közepes

A depresszió kétirányú kapcsolatban áll a demenciával: a kezeletlen depresszió emeli a későbbi demencia kockázatát, és a korai demencia tüneteit gyakran depressziónak nézik. A kezelés (akár gyógyszer, akár pszichoterápia, akár kombináció) protektív hatású.

Ezen a héten: Ha az elmúlt két hétben gyakran érezted magad reménytelennek vagy érdeklődés nélkülinek, beszélj a háziorvosoddal egy PHQ-9 önkitöltő kérdőívről. Ez 9 kérdés, 5 perc — és kiindulópont, nem diagnózis.

„A depresszió nem gyengeség, és a kezelése nem szégyen. Az agy egy szerv, és a szervek néha segítségre szorulnak.”

Forrás: Livingston et al., Lancet 2024.

07 — Fizikai inaktivitás → rendszeres mozgás

PAF: ~2% · *Középkor és időskor* · Bizonyíték: erős

A rendszeres testmozgás védi az agyat — keringés-javító, gyulladáscsökkentő, és neurotrofikus faktorok (BDNF) termelését serkenti. A WHO ajánlása: heti **150 perc közepes intenzitású**, vagy 75 perc magas intenzitású aerob mozgás, plusz heti 2 alkalom erősítő mozgás.

Nem a maraton számít. A *konzisztencia* számít.

Ezen a héten: Foglald be a naptáradba az elkövetkező 7 napra a mozgást — minden nap, néven nevezve. „Hétfő 18:00 — 30 perc séta a parkban.”

„A mozgás nem büntetés a testednek. A mozgás az egyetlen olyan beavatkozás, ami egyszerre véd a szívedtől, az érrendszered, a kedélyed és az agyad ellen — anélkül, hogy valamit fel kellene áldoznod érte.”

Forrás: Livingston et al., Lancet 2024; WHO 2020 ajánlás.

o8 — Szociális kapcsolatok ápolása

PAF: ~5% · *Időskor* · Bizonyíték: közepes-erős

A szociális izoláció — a magány tárgyilagos, mért formája — emeli a demencia kockázatát. Ez nem ugyanaz, mint introvertáltnak lenni. Az izoláció azt jelenti: kevés mély, rendszeres kapcsolat.

A FINGER vizsgálat (Finnország, 2015) is megerősítette, hogy a kapcsolati háló része a többdomain-protektív életmódnak.

Ezen a héten: Írj egy listát 5 emberről, akiket fontosnak tartasz, és akivel az elmúlt 3 hónapban kevesebb mint havi egyszer beszéltél. Hívd fel az elsőt ezen a héten.

„A kapcsolat nem szám kérdése. Egy mély beszélgetés egy emberrel heti egyszer többet véd, mint száz felületes ismerős.”

Forrás: Livingston et al., Lancet 2024; Ngandu et al., FINGER trial, Lancet 2015.

09 — Túlzott alkoholfogyasztás

PAF: ~1% · Középkor és időskor · Bizonyíték: közepes

A heti 21 standard ital (kb. 14 dl bor, vagy 21 dl sör) feletti rendszeres fogyasztás emeli a demencia kockázatát. Az alacsonyabb mennyiségek hatása vitatott — a régebbi „a vörösbor véd” állítás nagyrészt megdőlt; a jelenlegi konszenzus az, hogy nincs olyan alkoholmennyiség, ami bizonyítottan protektív.

A reális cél: a túlfogyasztás elkerülése. Nem a teljes absztinencia, ha az nem fenntartható.

Ezen a héten: Egy hétig naplózd, mennyit iszol. Csak megfigyelés, nem ítélet. A legtöbb ember kétszer annyit iszik, mint amennyit emlékezete szerint.

„Az alkohollal kapcsolatban a legnagyobb veszély a megfigyelés hiánya. Először lássuk meg, mennyi van — utána eldönthetjük, mit kezdjünk vele.”

Forrás: Livingston et al., Lancet 2024.

10 — Fejsérülések megelőzése

PAF: ~3% · Bármely életkor · Bizonyíték: erős

A traumás agysérülés (TBI), különösen az ismétlődő enyhe sérülések (sport, közlekedés), emeli a későbbi demencia kockázatát.

Ezen a héten:

- Ha biciklizel: viselj sisakot, kivétel nélkül.
- Ha autózol: az övet mindig becsatold, hátul is.
- Ha 65+ év felé közeledsz a háztartásban: nézd meg a csúszós szőnyegeket, a rossz világítást a lépcsőházban — az időskori esés a leggyakoribb TBI-ok.

„A megelőzés itt boring. Sisak. Öv. Jó cipő. Lámpa a folyosón. Boring — és működik.”

Forrás: Livingston et al., Lancet 2024.

II — Légszennyezettség-expozíció csökkentése

PAF: ~3% · *Bármely életkor* · Bizonyíték: közepes

A finom porszennyezés (PM2.5) hosszú távú expozíciója emeli a demencia kockázatát — neuroinflammatorikus mechanizmuson keresztül. Ez Magyarországon nem mellékes: Budapest és néhány nagyváros téli PM2.5-szintje meghaladja a WHO határértékét.

Ezen a héten:

- Tölts le egy levegőminőség-appot (pl. IQAir, EEA), és nézd meg a lakhelyed adatait.
- Ha rossz napon vagy, csökkentsd a kültéri sportot, és szellőztetésnél tartsd szemmel az időablakot (általában reggel jobb, mint csúcsforgalom idején).
- Ha lehetőséged van: HEPA-szűrős légtisztító a hálósobába.

„A levegő nem személyes hibád. De a megfigyelése — és a HEPA-szűrő — a kontrollodban van.”

Forrás: Livingston et al., Lancet 2024.

12 — Látásromlás-korrekción (új 2024)

PAF: ~2% · *Időskor* · Bizonyíték: közepes (új, 2024-ben került be a listára)

A 2024-es Lancet-frissítés két új faktorral bővült: az egyik a kezeletlen látásromlás. Hasonló mechanizmus, mint a hallásnál: szenzoros deprivációval emelkedik a kognitív hanyatlás kockázata, és a szociális izolációhoz is hozzájárul.

A jó hír: a leggyakoribb okok — szürkehályog, refrakciós hibák (rövid- vagy távollátás), makula-degeneráció — kezelhetők.

Ezen a héten: Ha 50 év feletti vagy és az elmúlt 2 évben nem voltál szemészeti vizsgálaton, foglalj időpontot. Nemcsak látásélességet mérnek — szemfenéki vizsgálattal a glaukómát és a makulát is.

„A jó látás nem hiúság. A jó látás azt jelenti, hogy a világ tisztán érkezik be hozzád — és az agyad nem fárad ki a megfigyelésen.”

Forrás: Livingston et al., Lancet 2024.

Amit hagyj figyelmen kívül

Ezen az oldalon olyan dolgokat sorolok fel, amelyeket a marketing rendszeresen demencia-megelőzésként pozicionál — de a jelenlegi tudományos bizonyítékok ezt nem támasztják alá. Nem azt mondom, hogy biztosan nem működnek. Azt mondom: nincs olyan minőségű evidence, ami alapján *nekem*, mint szakembernek, ajánlanom kellene neked, hogy költs rájuk.

1. Általános „agyvitaminok” és multivitamin-keverékek. A nagy, jól tervezett vizsgálatok (pl. COSMOS-Mind, 2023) nem mutattak konzisztens védőhatást. Ha B12- vagy D-hiányod van, kezelni kell — de a tüneti hiány ≠ rutin szupplementáció.

2. Kókuszolaj. A „közepes láncú trigliceridek megvédik az agyat” állítás egy kicsi, módszertanilag gyenge vizsgálatból nőtt ki. Nincs replikált bizonyíték. A magas telített zsírtartalom miatt rutinszerű fogyasztása inkább *árt*, mint használ.

3. Ginkgo biloba. A legnagyobb klinikai vizsgálat (GEM Study, 2008) nem talált demencia-megelőző hatást idős felnőtteknél. Vannak interakciói vérálvadás-gátlókkal.

4. Brain-training appok (a legtöbb). A Lumosity, Elevate stb. típusú appok abban a játékban tesznek jobba, amit játszol. A *transzfer* — vagyis hogy ez általános kognitív védelmet adna — a független meta-analízisek szerint nagyon gyenge. Inkább tanulj nyelvet, hangszer vagy szakmát.

5. „Megfiatalító” peptidek, NAD+ infúziók, exoszóma-terápiák. A demencia-prevenációs állítások itt teljesen evidence-mentesek. Drágák, és néhány kockázattal is járhatnak.

6. „Csodaszuperélelmiszer” porok és koncentrátumok. A teljes kiőrlésű gabonát, halat, zöldséget, olívaolajat tartalmazó MIND vagy mediterrán étrend mutat enyhe védőhatást — de ez nem por formájában jön, és nem 25 ezer forintba kerül havonta.

A közös szabály: ha egy termék a demencia-megelőzést használja marketingre, és nem hivatkozik nagy, randomizált klinikai vizsgálatra, ami szerepel a Lancet Commission referenciái között — *valószínűleg nem ér annyit, amennyit kérnek érte.*

Heti 7 lépés-protokoll

Ne kezdj el holnap reggel mind a 12 dolgot. Az alábbi 7 nap mindegyikére egy konkrét, kis lépés tartozik — ezek mind a 12 faktor egyikéhez kapcsolódnak. A cél: a hét végén egy kicsi, *valódi* alapozás legyen meg.

1. nap (hétfő) — Vérnyomás Foglalj időpontot a házi orvosodhoz vérnyomásmérésre. Ha van otthoni mérőd, mérd meg háromszor, ülve, nyugodtan, 1 perc különbséggel. Írd le az átlagot.

2. nap (kedd) — Hallás vagy látás Ha 50+ vagy és az elmúlt 2-3 évben nem voltál szemészeten/audiológian, foglalj időpontot. (Válassz egyet közülük — a másikra a következő hónapban.)

3. nap (szerda) — Mozgás Tegyéi be a naptáradba az elkövetkező 7 napra **3 mozgásalkalmat**, néven nevezve (mit, hol, mennyit). Pl. „szombat 9:00 — 45 perc gyaloglás a parkban”.

4. nap (csütörtök) — Kapcsolat Írj egy listát 5 emberről, akiket fontosnak tartasz, de ritkán látsz/hallasz. Hívd fel az elsőt. Ne SMS — telefon vagy személyes.

5. nap (péntek) — Tanulás Válassz egy témát, amit régóta szeretnél volna megérteni. Iratkozz fel egy könyvre, kurzusra, podcastra. Nem agytorna-app. Valódi, struktúrált tudás.

6. nap (szombat) — Mentális egészség check Töltsd ki magadnak a PHQ-9 önkitöltő kérdőívet (interneten ingyenesen elérhető magyarul). Ha közepes-súlyos depresszióra utal, foglalj időpontot. Ha nem: jó, hogy ránéztél.

7. nap (vasárnap) — Áttekintés Ül le 15 percre, és nézd át a hetet. Mit sikerült? Mit nem? *Ne legyél magaddal szigorú.* Tűzz ki **egyetlen** apró célt a következő hétre — pl. „minden reggel 7 perc séta”, vagy „heti egyszer hosszú telefon egy régi baráttal”.

A demencia-megelőzés egy évtizedes projekt. Az első hét nem versenytávolság — alapozás.

Mit ne csinálj

Ennek a fejezetnek a célja, hogy megóvjon néhány gyakori csapdától, amibe sok jószándékú ember beleesik, amikor felfedezi a demencia-megelőzés témáját.

1. Ne pánikolj egy gyenge online memóriateszt-eredmény miatt. Az online tesztek a legjobb esetben tájékoztató jellegűek, a rosszabbik esetben pontatlanok. Ha aggódsz a memóriád miatt, kérj időpontot szakorvoshoz — ne a Google-tól kérj diagnózist hajnali kettőkor.

2. Ne kezdj el 10 dolgot egyszerre. Az életmódváltási kutatások egyértelműek: aki egyszerre próbál mindent megváltoztatni, 3-4 héten belül feladja az egészet. *Egy faktor egy negyedévre* — sokkal hatékonyabb.

3. Ne hidd, hogy a genetika determinál. Erről írtam fent. Az APOE4 hordozók is profitálnak ugyanezekből a lépésekből.

4. Ne költs csodaszerekre. A demencia-megelőzés ipara tele van pszeudo-tudományos termékekkel. Ha valami nem hivatkozik nagy, randomizált, peer-reviewed vizsgálatra: szkeptikus légy. (És az „egy tanulmány szerint” kezdetű marketing-mondat is gyanús.)

5. Ne tegyél úgy, mintha a stressz-szint nem számítana. Bár a krónikus stressz nem szerepel a Lancet Commission 12 fő faktorában (mert nehéz tisztán mérni), közvetetten — depresszión, alváson, vérnyomáson keresztül — érinti az agyad. Vedd komolyan, anélkül, hogy túlpörgetnéd.

6. Ne szigetelődj el azért, mert szégyenkezel a memóriakiagyásaid miatt. Mindenki felejt. Egy 50 éves agy másképp működik, mint egy 25 évesé — ez NEM demencia. Az izoláció önbeteljesítő jóslat: pont az emelné a kockázatot, ami elől menekülnél.

Következő lépés

Ez a füzet a megelőzés alapját adja át — a nemzetközi tudományos konszenzust, magyarul, használhatóan. De a tudás önmagában nem elég: a legtöbb embernek **kontextus**, **kísérés** és néhány személyre szabott válasz kell ahhoz, hogy ezekből a faktorokból valódi szokás legyen.

Ezért készítettem két lehetőséget arra, hogy ne maradj egyedül a kérdéseiddel:

1. Preventív online edukációs anyag — egy mélyebb, ~3 órás videó- és írott anyag, ami minden faktort egyenként, részletesen bont ki, magyar kontextusban (mely vizsgálatok ingyenesek itt, hol érhető el az adott szolgáltatás, milyen életkorban mi a prioritás). Tartalmaz egy önértékelő kérdőívet is, ami segít a saját rizikóprofilodat strukturáltan átgondolni.

2. 30 perces preventív konzultáció — videóhíváson személyesen átbeszéljük a családi anamnézisedet, az aktuális életmódodat és azt a 2-3 faktort, amire a legtöbbet érdemes fókuszálnod. Nem orvosi diagnózis — szakértői átbeszélés, ami egy strukturált tervet ad a kezvedbe.

A részleteket itt találod: vivien.hu/megelozes (Ha PDF-ben olvasod: a Vivien-weboldal kapcsolat-aloldaláról elérhető mindkét opció.)

Ha most még csak olvasni szeretnél: rendben. Ez is haladás. Az életkori protektív hatás évtizedek alatt épül — egy *nyugodt, kitartó* megközelítés többet ér, mint egy lelkes hat hét.

Forrás-jegyzék

Az ebben a magnetben szereplő számok, becslések és ajánlások az alábbi forrásokra épülnek. A teljes hivatkozásokat a tudományos formátumnak megfelelően adom meg, hogy ha érdekel, magad is utánanézhess.

Elsődleges forrás (a 12 faktor és a PAF-becslések):

- Livingston G, Huntley J, Liu KY, et al. *Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission*. *Lancet* 2024;404(10452):572–628.
- Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, et al. *Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission*. *Lancet* 2020;396(10248):413–446.

Klinikai vizsgálatok, amelyekre hivatkoztam:

- **Hallás (ACHIEVE trial):** Lin FR, Pike JR, Albert MS, et al. *Hearing intervention versus health education control to reduce cognitive decline (ACHIEVE)*. *Lancet* 2023;402(10404):786–797.
- **Vérnyomás (SPRINT-MIND):** Williamson JD, Pajewski NM, Auchus AP, et al. *Effect of intensive vs standard blood pressure control on probable dementia*. *JAMA* 2019;321(6):553–561.
- **Multidomain életmód (FINGER trial):** Ngandu T, Lehtisalo J, Solomon A, et al. *A 2-year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people*. *Lancet* 2015;385(9984):2255–2263.

Étrend:

- Morris MC, Tangney CC, Wang Y, et al. *MIND diet associated with reduced incidence of Alzheimer's disease*. *Alzheimers Dement* 2015;11(9):1007–1014.

Multivitamin:

- Baker LD, Manson JE, Rapp SR, et al. *Effects of cocoa extract and a multivitamin on cognitive function (COSMOS-Mind)*. *Alzheimers Dement* 2023;19(4):1308–1319.

Általános referenciák:

- Alzheimer's Association. *2024 Alzheimer's Disease Facts and Figures*. *Alzheimers Dement* 2024;20(5):3708–3821.
- WHO. *Risk reduction of cognitive decline and dementia: WHO guidelines*. Geneva: World Health Organization, 2019.
- US Preventive Services Task Force. *Screening for Cognitive Impairment in Older Adults: Recommendation Statement*. *JAMA* 2020;323(8):757–763.

Ha bármely állítást vitatottnak vagy elavultnak találnál, kérlek jelezd — ez a magnet élő anyag, és minden új Lancet-jelentésnél frissítem.

Rólam — Vivien

Demenciaszakértő vagyok, és az elmúlt években több száz családdal dolgoztam együtt — egyrészt a már fennálló demencia melletti gondozásban, másrészt — és ez egyre fontosabb — a *megelőzés* oldalán is.

Hogy miért írom a magnetet most: mert a középkorú generáció — azok, akiknek a szülei demenciával éltek — gyakran két véglet között őrlődik. Az egyik a fatalista beletörődés („úgyis genetika”), a másik a pánikszerű kapkodás, amibe drága, haszontalan termékek és terápiák lopóznak be. Egyik sem szolgálja a valódi *biztonságot*.

A célom egyszerű: olyan tudást adni, amire 10 év múlva is büszke leszek — és amit egy *érett, érzelmileg stabil* felnőtt használni tud, anélkül, hogy szorongana, vagy anélkül, hogy a megelőzés a következő gyűlölnivaló kötelességévé válna.

Elérhetőségek:

- Weboldal: vivien.hu
- E-mail: vivien@vivien.hu *(példa — a tényleges email a weboldalon)*
- Időpontfoglalás 30 perces preventív konzultációra: vivien.hu/megelozes

Köszönöm, hogy időt szántál erre. Ha egyetlen dolgot viszel magaddal: nem a genetika a sorsod, és nem 60% a megoldás. **A nyugodt, kitartó, középkori figyelem** a megoldás — és ez a kezeden van.

Vivien